

Examen Classant National Q12- Cancer du Cavum

(Questions non faites pendant la séance)

QCM 1

Quelle est la répartition d'âge pour la survenue du CNP dans les pays à risque intermédiaire ?

- A. Pic unique à 50 ans
- B. Bimodale : entre 10 et 24 ans, et à 50 ans
- C. Pic unique à 30 ans
- D. Bimodale : entre 30 et 40 ans, et à 60 ans
- E. Âge moyen supérieur à 50 ans

QCM 2

Les tumeurs hémato-lymphoïdes :

- A. Sont les tumeurs non épithéliales les plus fréquentes
- B. Suivent la répartition de l'UCNT
- C. Sont souvent de type lymphome B
- D. Sont liées à l'infection EBV
- E. Sont liées au tabac

QCM 3

Quels marqueurs sont trouvés dans les cellules malignes des CNP types UCNT ? :

- A. ADN viral
- B. IgA anti-VCA
- C. LMP1 (latent membrane protein)
- D. IgG anti-EBV
- E. IgM anti-EBV

QCM 4

Quelle protéine virale est associée à un pouvoir oncogène probable dans les CNP types UCNT ?

- A. EA (early antigen)
- B. VCA (viral capsid antigen)
- C. LMP1 (latent membrane protein)
- D. EBNA (Epstein-Barr nuclear antigen)
- E. LMP2 (latent membrane protein 2)

QCM 5

Les facteurs viraux incriminés dans la genèse des CNP :

- A. L'infection par HPV est responsable des carcinomes kératinisant
- B. L'EBV est le facteur étiologique le plus important de l'UCNT
- C. L'ADN viral est détecté dans près de 100% des UCNT
- D. La mise en évidence du LMP1 se fait dans le sang
- E. Le LMP 1 a un pouvoir oncogène très probable

QCM 6

Quels signes rhinologiques peuvent être présents lors de la première consultation pour un CNP ?

- A. Obstruction nasale que si la tumeur dépasse les choanes
- B. Trouble de l'odorat
- C. Bourdonnements d'oreille
- D. Autophonie
- E. Rhinorrhée mucosanglante

QCM 7

Le syndrome paranéoplasique au cours du cancer du cavum :

- A. Se voit dans moins de 10% des cas
- B. Évolue dans le sens contraire de la maladie
- C. Peut mimer une autre maladie maligne
- D. Se voit chez le sujet jeune
- E. Est aggravé par le tabagisme

QCM 8

Sont de mauvais pronostic au cours du cancer du nasopharynx :

- A. T3
- B. N3
- C. UCNT
- D. Rechute
- E. Extension vers le sinus caverneux

QCM 9

Quelle(s) localisation des adénopathies est un facteur de mauvais pronostic pour le CNP ?

- A. Au-dessous du bord inférieur du cartilage thyroïde
- B. Sous le bord inférieur du cartilage cricoïde
- C. Au niveau des ganglions médiastinaux
- D. Au niveau des ganglions occipitaux
- E. Au niveau des ganglions axillaires

QCM 10

Le CNP révélé par ADP en apparence primitive :

- A. Peut-être diagnostiqué par cytoponction ganglionnaire
- B. Nécessite une panendoscopie avant toute cervicotomie
- C. La sérologie EBV confirme le diagnostic
- D. Le PET scan permet de chercher le primitif et faire le bilan d'extension
- E. L'adénectomie peut aggraver le pronostic

QCM 11

Le CNP doit être évoqué devant :

- A. Toute otite séromuqueuse
- B. Un trismus douloureux
- C. Un syndrome cérébelleux
- D. Fièvre au long cours
- E. Des douleurs articulaires

QCM 12

Quel examen est essentiel pour évaluer l'extension ganglionnaire dans le CNP ?

- A. IRM du cavum
- B. Scanner du cavum
- C. PET-scan
- D. Sérologie EBV
- E. Ponction cytologique ganglionnaire à l'aiguille fine

QCM 13

Quel est l'objectif principal de l'IRM du cavum dans le cadre du CNP ?

- A. Détecter les adénopathies cervicales
- B. Apprécier l'extension en profondeur et l'atteinte des nerfs crâniens
- C. Analyser les processus muqueux débutants stade T1
- D. Différencier une fibrose post-thérapeutique d'une rechute locale
- E. Toutes les réponses sont correctes

QCM 14

L'imagerie au cours du CNP :

- A. La TDM doit se faire de la base du crâne au creux sus claviculaire
- B. La TDM est sensible à l'analyse de la corticale osseuse
- C. L'IRM est utile pour différencier la tumeur de la fibrose
- D. Le Pet Scan est supérieur dans l'analyse des extensions locales de la tumeur que l'IRM
- E. Permet d'évaluer l'atteinte ganglionnaire rétropharyngée

QCM 15

La chimiothérapie au cours des CNP :

- A. Est plus efficace sur le carcinome kératinisant
- B. Utilise la gemcitabine qui est particulièrement efficace
- C. A utilisé en adjuvant car elle prévient les métastases
- D. En concomitant avec la radiothérapie, elle améliore la survie globale et sans maladie
- E. A un effet cytotoxique systémique

CAS CLINIQUE 2

Un patient de 45 ans se présente avec des adénopathies cervicales bilatérales, hautes et postérieures.
Il se plaint également de morsure linguale droite récidivante.
Il a un depuis quelques semaines une chute de l'épaule droite.
Le carcinome du nasopharynx est suspecté.

QCM 16

Comment expliquer la morsure de la langue répétée ?

- A. Extension à l'oropharynx
- B. Extension au foramen jugulaire
- C. Extension à l'espace rétrostylien
- D. Extension au muscle ptérygoïdien médial
- E. Syndrome paranéoplasique

QCM 17

Comment expliquer la chute de l'épaule ?

- A. Métastase osseuse
- B. Adénopathie axillaire
- C. Atteinte du plexus cervical profond
- D. Extension de la tumeur en rétrostylien
- E. Extension au foramen jugulaire

QCM 18

Sur la base de ces données, comment est classée au minimum la tumeur ?

- A. T4N1
- B. T3N3
- C. T4N2
- D. T4N2c
- E. T2N2

QCM 19

Après la fin du traitement, quels sont les effets secondaires à craindre ?

- A. Hypothyroïdie
- B. Toxicité rénale
- C. Toxicité nerveuse cérébrale
- D. Ostéoradionécrose
- E. Toxicité pulmonaire